

Fecha Última Actualización: 26-08-2022 21:13:08

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Eliana Del Carmen Guerrero Cabello
Edad : 75a 1m 10d
Dirección : Orilla Del Rio, Paradero 11. S/N

Rut : 5.049.670-8
Fecha Nacto: 16/07/1947
Comuna : Pirque

N° Archivo : A047811
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 4080 2930

N° Epicrisis
320772

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Ingreso : 14/08/2022 05:46

Días Estadía: 12

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 26/08/2022 21:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor extremidades inferiores

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Embolectomía Y/O Trombectomía, Unilateral, Miembro Superior O Inferior (Proc. Aut.) - 15/08/2022 00:00 - Cristian Marin Oviedo
Amputación Pierna - 18/08/2022 00:00 - Cristian Marin Oviedo

Epidemiología

Resumen Clínico

Egreso UCI

Nomnbre:Eliana Guerrero
FI CASR: 13/08/2022
Estadía recuperación: 16/08/2022-18/08/2022
Estadía cirugía A: 18/08/2022-25/08/2022
FI UCI: 25/08/2022
FE UCI: 26/08/2022

Antecedentes

-DM2 IR
-HTA
-Coxartrosis
-Alergia: PNC
-Múltiples hospitalizaciones recientes
o27/06/2022 ¿ 02/07/2022: ITU alta + obstrucción intestinal x fecaloma
o12/07/2022 ¿ 12/07/2022: Sepsis de foco abdominal x proctocolitis
o25/07/2022 ¿ 11/08/2022: Isquemia aguda sobre crónica EID
§Embolectomía + fasciotomía de EID

Motivo de consulta

Paciente con atcd descritos y múltiples hospitalizaciones previas. Consultó en UEA el 13/08/22 por de ambas extremidades inferiores asociado a dehiscencia de suturas de fasciotomía reciente + dolor en brazo derecho. Al examen físico se apreciaba edema importante de ambas EEII junto con secreción hemopurulenta desde herida de fasciotomía + edema, eritema y aumento de temperatura local de brazo derecho, sin otros hallazgos significativos al examen físico. Impresionaba TVP izquierda junto con nueva oclusión arterial aguda de EID. Se hospitaliza para estudio y manejo.
Eco Doppler (14/08): TVP femoropoplítea izquierda no oclusiva

Fecha Epicrisis : 26/08/2022 21:13

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:46

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 26-08-2022 21:13:08

Página 2 de 3

Angio TAC AP + EEII (14/08): Oclusión de arteria poplítea derecha sin flujo hacia distal. Trombo no oclusivo en el aspecto distal de arteria ilíaca común - origen de la arteria ilíaca externa derecha. Oclusión de arteria tibial anterior izquierda. Moderada a acentuada aterosclerosis aórtica y de sus ramas difusa. Signos de procto-colitis de probable carácter inflamatoria infecciosa. Moderado derrame pleural bilateral con atelectasias pasivas.

Se realiza embolectomía de urgencia el 15/08, evolución tórpida. Paciente con mucho dolor en relación a extremidad intervenida, impresiona trombectomía no satisfactoria por lo que se decide amputación supracondílea derecha. Nueva intervención realizada el 18/08, paciente sale estable a recuperación y posteriormente a sala de cirugía.

Evoluciona en sala en malas condiciones dada alteraciones en intercambio gaseoso, con requerimiento de O2 suplementario $\dot{V}_{\text{FiO}_2}$ hasta 60% con VMNI. Destacaba crépitos en ambas bases pulmonares junto con edema generalizado. Pese a medidas previas, paciente persiste desaturando, con mala mecánica ventilatoria y compromiso de conciencia motivo por el cual se realiza intubación el 25/08 durante la mañana. Paciente se traslada a Recuperación y posteriormente se solicita traslado a UPC.

Diagnósticos de ingreso a UCI

- SDRA en estudio
- TVP femoro-poplítea izquierda
- Enfermedad arterial oclusiva $\dot{V}_{\text{FiO}_2}$ isquemia aguda sobre crónica
- o2 embolectomías frustras en EID (26/07/22 y 15/08/22)
- oAmputación supracondílea EID (18/08/22)
- Antecedentes

Evolución en UCI

Hemodinamia

Paciente grave, muy inestable, taquicardia hasta 150lpm, con requerimiento de DVA al alza, actualmente NAD 0.5ug/kg/min manteniendo PAM entre 55-60mmHg. Sin sangrado ni requerimientos transfusionales agudos. Se decide inicio de vasopresina para PAM > 65mmHg. Microperfusión con lactato 18.2. Evoluciona durante la tarde de hoy, presenta TV sin pulso, iniciándose RCP avanzada: 2mg adrenalina, 3 desfibrilaciones 200J, todos los ciclos en TV sin pulso, sin respuesta a maniobras.

Respiratorio

En VMI bien acoplada, cursando con SDRA de causa desconocida; ventilación con parámetros protectores pero severa alteración de intercambio gaseoso, hoy exámenes de control con pH 7.11, PCO2 65, PO2 63, HCO3 20, Sat 89%

Se intenta realizar AngioTC Torax durante la tarde, el cual es frustrado por problemas en TAC. Evoluciona con SDRA severo, con incremento de requerimientos de $\dot{V}_{\text{FiO}_2}$ hasta 70%.

Infeccioso

Parámetros inflamatorios al alza con alza térmica, subfebril hasta 37.6°C. Se encontraba en tratamiento con AMS (atcd de alergia a PNC). Se ajusta esquema ATB a Imipenem/Vanco. Cultivos tomados el día de hoy sin crecimiento precoz de bacterias.

Renal

Oligúrica ayer, sin alteraciones significativas de función renal. ELP dentro de rango. En observación ante requerimiento de TRR

Profilaxis

Ingresa con dosis anticoagulante de HBPM debido a atcd de TVP. Sin mayor conflicto de momento

Quirúrgico

Muñón de amputación sin sangrado ni secreción activas, sin signos de sobreinfección local. Cubierto por apósito limpio y seco
Plan: sin mayor conflicto actual

Evoluciona durante la tarde del 26.08 con TV sin pulso aprox 8:10pm. Se inicia maniobras de RCP avanzado: 2mg adrenalina, 3 desfibrilaciones 200J, todos los ciclos en TV sin pulso, sin respuesta a maniobras RCP. Se declara fallecimiento a las 20:35hrs. Se avisa a familiares

Diagnósticos de Egreso UCI:

Fecha Epicrisis : 26/08/2022 21:13

Página 2 de 3

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 26-08-2022 21:13:08

Página 3 de 3

-SDRA en estudio
-TVP femoro-poplítea izquierda
-Enfermedad arterial oclusiva ¿ isquemia aguda sobre crónica
o2 embolectomías frustras en EID (26/07/22 y 15/08/22)
oAmputación supracondílea EID (18/08/22)
-DM2 IR
-HTA
-Coxartrosis
-Alergia: PNC
-Múltiples hospitalizaciones recientes
o27/06/2022 ¿ 02/07/2022: ITU alta + obstrucción intestinal x fecaloma
o12/07/2022 ¿ 12/07/2022: Sepsis de foco abdominal x proctocolitis
o25/07/2022 ¿ 11/08/2022: Isquemia aguda sobre crónica EID
§Embolectomía + fasciotomía de EID

Diagnóstico de Egreso

Choque séptico - -SDRA en estudio
-TVP femoro-poplítea izquierda
-Enfermedad arterial oclusiva ¿ isquemia aguda sobre crónica
o2 embolectomías frustras en EID (26/07/22 y 15/08/22)
oAmputación supracondílea EID (18/08/22)
-DM2 IR
-HTA
-Coxartrosis
-Alergia: PNC
-Múltiples hospitalizaciones recientes
o27/06/2022 ¿ 02/07/2022: ITU alta + obstrucción intestinal x fecaloma
o12/07/2022 ¿ 12/07/2022: Sepsis de foco abdominal x proctocolitis
o25/07/2022 ¿ 11/08/2022: Isquemia aguda sobre crónica EID
§Embolectomía + fasciotomía de EID

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

fallecido

Plan Post Alta

fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Gonzalo Núñez Muñoz
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 26/08/2022 21:13

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:46

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar